

Tratamiento antipsicótico: típicos y atípicos

1. Introducción y relevancia clínica

Los **antipsicóticos** son los fármacos fundamentales para el tratamiento de los **trastornos psicóticos** (esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, psicosis agudas y trastornos bipolares con síntomas psicóticos).

Desde su introducción en los años 50 con la **clorpromazina**, los antipsicóticos han revolucionado la psiquiatría al permitir la **estabilización y reintegración social** de miles de pacientes que antes permanecían institucionalizados.

Actualmente se dividen en dos grandes grupos:

Tipo	Generación	Características principales
Típicos (convencionales)	1ª generación	Potente bloqueo D_2 , más síntomas extrapiramidales, menos efectos metabólicos.
Atípicos (de nueva generación)	2ª generación	Bloqueo combinado D_2 y $5-HT_2A$, mejor perfil extrapiramidal, eficacia en síntomas negativos y afectivos.

□ **EUNACOM pregunta frecuente:**

- Mecanismo de acción de típicos vs atípicos.
- Efectos adversos extrapiramidales y manejo.
- Indicaciones específicas (p. ej. clozapina en esquizofrenia resistente).
- Uso de antipsicóticos de depósito para mejorar adherencia.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Vías dopaminérgicas cerebrales

Vía	Función normal	Efecto del bloqueo dopaminérgico
Mesolímbica	Regulación de la motivación y recompensa	↓ Psicosis positiva (efecto terapéutico)
Mesocortical	Cognición y afecto	↑ Síntomas negativos y cognitivos
Nigroestriada	Control motor extrapiramidal	Efectos extrapiramidales
Tuberoinfundibular	Inhibición de prolactina	Hiperprolactinemia

El bloqueo de **receptores D₂** en estas vías explica tanto los **efectos terapéuticos como los secundarios** de los antipsicóticos.

2.2. Diferencias farmacológicas clave

Característica	Típicos	Atípicos
Mecanismo principal	Bloqueo D ₂	Bloqueo D ₂ + 5-HT ₂ A (serotonina)
Afinidad dopaminérgica	Alta	Moderada
Efectos extrapiramidales (EPS)	Frecuentes	Raros
Eficacia en síntomas negativos	Limitada	Buena

Efectos metabólicos	Mínimos	Comunes (aumento de peso, dislipidemia)
Hiperprolactinemia	Frecuente	Rara (excepto risperidona)

2.3. Hipótesis serotoninérgica

Los **antipsicóticos atípicos** actúan bloqueando simultáneamente receptores **D₂** y **5-HT_{2A}**, lo que modula la liberación dopaminérgica en la corteza prefrontal.

Esto **mejora síntomas negativos** y reduce los **efectos extrapiramidales**, por liberación compensatoria de dopamina en la vía nigroestriada.

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial de efectos adversos)

3.1. Efectos terapéuticos esperados

- Disminución de **alucinaciones, delirios y agitación**.
- Mejora de la organización del pensamiento.
- Reducción de la agresividad o conducta desorganizada.
- Algunos atípicos mejoran la **afectividad y cognición**.

Latencia de acción:

- Control de agitación: horas.
 - Síntomas positivos: días a semanas.
 - Síntomas negativos y funcionalidad: 4–6 semanas o más.
-

3.2. Efectos adversos frecuentes

a. Efectos extrapiramidales (EPS)

Por bloqueo dopaminérgico nigroestriado.

Tipo	Tiempo de aparición	Manifestaciones	Manejo
Distonía aguda	Horas–días	Contracciones musculares, tortícolis, crisis oculógira	Anticolinérgico (biperideno IM)
Parkinsonismo farmacológico	Semanas	Rigidez, temblor, bradicinesia	Biperideno o trihexifenidilo VO
Acatisia	Días–semanas	Inquietud motora, ansiedad	Benzodiacepinas o betabloqueadores
Discinesia tardía	Meses–años	Movimientos involuntarios orofaciales	Suspender fármaco, cambiar a clozapina

❑ **EUNACOM:** identificar acatisia vs ansiedad y distonía aguda (emergencia tratable).

b. Síndrome neuroléptico maligno (SNM)

Complicación rara pero potencialmente fatal.

- Fiebre >38,5°C
- Rigidez muscular “en tubo de plomo”
- Alteración del sensorio
- Elevación de CPK, leucocitosis, mioglobinuria

Manejo:

1. Suspender antipsicótico.
2. Hidratar y manejar hipertermia.

3. **Dantroleno IV y/o bromocriptina.**

4. Cuidados intensivos.

c. Hiperprolactinemia

Más común con **típicos** y **risperidona**.

- Galactorrea, amenorrea, ginecomastia, disfunción sexual.

→ Cambiar a **aripiprazol o quetiapina**.

d. Efectos metabólicos

Predominan en atípicos, especialmente **olanzapina y clozapina**:

- Aumento de peso.
- Dislipidemia, resistencia insulínica.
- Síndrome metabólico (control semestral de IMC, glicemia y perfil lipídico).

e. Efectos cardiovasculares

- **Prolongación QT:** haloperidol, ziprasidona.
- **Hipotensión ortostática:** por bloqueo α_1 .
- Evitar combinaciones con otros fármacos que prolonguen QT (macrólidos, fluoroquinolonas).

f. Otros efectos

- Sedación (bloqueo H_1): clorpromazina, quetiapina.
- Anticolinérgicos (sequedad, constipación): clorpromazina, olanzapina.

- Agranulocitosis (rara): clozapina → control hematológico obligatorio.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

Aunque el diagnóstico es clínico, el uso de antipsicóticos exige **evaluaciones de seguridad y seguimiento**.

4.1. Evaluación basal

Antes de iniciar tratamiento:

- Peso, IMC, perímetro abdominal.
- PA, glicemia, perfil lipídico.
- Hemograma, creatinina, transaminasas.
- ECG (si riesgo cardiovascular o QT prolongado).

En clozapina: recuento de leucocitos y neutrófilos semanal x 6 meses, luego mensual.

4.2. Monitoreo durante el tratamiento

Parámetro	Frecuencia recomendada
Peso, PA, IMC	Mensual primeros 3 meses, luego semestral
Glicemia, lípidos	3 meses y luego cada 6–12 meses
ECG	Anual o ante síntomas
CPK	Solo si síntomas extrapiramidales severos

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

El **Ministerio de Salud de Chile (MINSAL)** recomienda los siguientes lineamientos generales (Guía Clínica Esquizofrenia, 2021):

5.1. Fase aguda

- **Primera elección:** antipsicótico atípico.
 - **Si paciente agitado:** haloperidol IM o risperidona VO, asociado a benzodiacepina (lorazepam).
 - Evaluar riesgo cardiovascular, peso y antecedentes metabólicos antes de elegir.
-

5.2. Fase de mantenimiento

- Continuar el mismo fármaco en dosis mínima eficaz.
 - Duración mínima: **12–24 meses tras el primer episodio.**
 - En recaídas: tratamiento prolongado o indefinido.
 - En adherencia deficiente: **formas depot (palmitato de risperidona, aripiprazol LAI).**
-

5.3. Esquizofrenia resistente

- Definida como falta de respuesta a **≥2 antipsicóticos distintos durante ≥6 semanas.**
- **Fármaco de elección: Clozapina.**

- Eficaz sobre síntomas positivos y suicidios.
- Requiere monitoreo hematológico riguroso.
- Dosis: 100–900 mg/día.

5.4. Elección de antipsicótico según perfil del paciente

Situación clínica	Antipsicótico recomendado
Obesidad / DM2	Aripiprazol, ziprasidona
Depresión comórbida	Quetiapina
Insomnio o ansiedad	Quetiapina, olanzapina
Riesgo extrapiramidal alto	Clozapina, quetiapina
Mala adherencia	Formas depot (risperidona LAI, aripiprazol LAI)

6. Complicaciones y pronóstico

Complicaciones

- Síndrome neuroléptico maligno.
- Discinesia tardía irreversible.
- Síndrome metabólico y diabetes.
- Hiperprolactinemia crónica.
- Agranulocitosis (clozapina).

Pronóstico

- Con tratamiento continuo, **70–80% de los pacientes esquizofrénicos logran estabilización.**
 - La adherencia es el factor pronóstico más importante.
 - Los **atípicos** mejoran calidad de vida, síntomas negativos y adherencia.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. **Antipsicóticos típicos:** potentes D_2 antagonistas, más efectos extrapiramidales.
 2. **Atípicos:** bloquean $D_2 + 5HT_2 A \rightarrow$ menos EPS, mejor efecto sobre negativos.
 3. **Clozapina:** elección en esquizofrenia resistente y suicidio persistente.
 4. **Risperidona:** eleva prolactina; **aripiprazol** puede reducirla.
 5. **Olanzapina y clozapina** causan mayor aumento de peso y dislipidemia.
 6. **Síndrome neuroléptico maligno:** fiebre, rigidez, CPK alto $\rightarrow$ suspender y hospitalizar.
 7. **Discinesia tardía:** cambiar a clozapina o reducir dosis del típico.
-



Errores comunes

- Iniciar antipsicótico sin evaluación basal (peso, glicemia).
- Tratar con dos antipsicóticos simultáneamente sin justificación.
- Usar haloperidol crónicamente en esquizofrenia sin monitoreo de EPS.

- Suspender bruscamente un antipsicótico (riesgo de rebote psicótico).
 - No reconocer síndrome neuroléptico maligno como urgencia vital.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Los **antipsicóticos típicos** bloquean D_2 y controlan síntomas positivos, pero causan más efectos extrapiramidales.
2. Los **atípicos** actúan sobre D_2 y $5-HT_2 A$, mejorando síntomas negativos y afectivos, con mejor tolerancia motora.
3. La **clozapina** es el fármaco de elección en **esquizofrenia resistente**, pero requiere control hematológico.
4. El **síndrome neuroléptico maligno** es una urgencia médica; debe sospecharse ante fiebre + rigidez + CPK elevado.
5. Los **efectos metabólicos** (peso, glicemia, dislipidemia) son frecuentes con olanzapina y clozapina.
6. La **adherencia terapéutica** se optimiza con formulaciones depot.
7. Todo paciente en tratamiento antipsicótico debe tener **monitoreo metabólico y cardiovascular regular**.